



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
TUBERKULOSIS PARU
RS PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

TUBERKULOSIS PARU

1. Pengertian (Definisi)	Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi di paru yang bersifat kronikdan menular disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis kompleks
2. Anamnesis	a. Batuk berdahak > 2-3 minggu b. Batuk darah c. Sesak nafas d. Nyeri dada e. Demam f. Lemah badan g. Penurunan nafsu makan h. Penurunan berat badan i. Keringat malam
3. Pemeriksaan Fisik	Kurang spesifik, tetapi bisa ditemukan suara nafas bronchial, amforik, suara nafas melemah, ronkhi basah, tergantung luas lesi
4. Kriteria Diagnosis	a. Anamnesa b. Pemeriksaan fisik c. Pemeriksaan sputum SPS (Sewaktu-Pagi-Sewaktu) dengan pengecatan ZN. d. Pemeriksaan foto torak didapatkan gambaran khas TB paru
5. Diagnosis Kerja	Tuberculosis of lung (ICD 10: A15)
6. Diagnosis Banding	a. Pneumonia b. Infeksi jamur paru c. Tumor paru
7. Pemeriksaan Penunjang	a. Pemeriksaan Bakteriologis (sputum BTA S/P/S) b. Pemeriksaan Radiologis (Foto toraks PA)
8. Terapi	Panduan OAT dan peruntukannya a. Kategori-1 (2HRZE/4H3R3) Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru : • Pasien baru TB Paru BTA positif • Pasien TB Paru BTA negatif foto toraks positif • Pasien TB ekstra paru b. Kategori-2 (2HRZES/HRZE/5H3R3E3) Panduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya : • Pasien kambuh • Pasien gagal • Pasien dengan pengobatan setelah default (terputus) c. OAT Sisipan (HRZE) Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif kategori 1 yang di berikan selama sebulan (28 hari)

	Pengobatan suportif dan simptomatis yang diberikan sesuai dengan keadaan klinis dan indikasi rawat.: 1. Perbaikan gizi 2. Pendidikan Kesehatan 3. Rehabilitasi medik
9. Edukasi	a. Edukasi tentang terapi OAT dan efek sampingnya b. Edukasi kontrol lingkungan (cara batuk, masker, ventilasi) c. Edukasi PMO (Pengawas Menelan Obat) d. Evaluasi terapi (pemeriksaan sputum dan foto toraks sesuai program) e. Edukasi kontrol rutin poli rawat jalan f. Edukasi sosial (pencarian kontak serumah)
10. Prognosis	Dubia ad bonam/malam
11. Kriteria Pulang	Kondisi umum membaik, paham tentang terapi OAT.
12. Tingkat Evidens	I
13. Tingkat Rekomendasi	A
14. Penelaah Kritis	dr. Catur Elvi Purnamawati, Sp.P (K) dr. Andy Sp.P (K)
15. Indikator Medis	Tidak sesak
16. Kepustakaan	a. Tuberkulosis, Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia, PDPI, 2011 b. Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, DEPKES, 2011

Clinical Pathway : Tuberculosa Paru

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. ASESMEN AWAL	Dokter Umum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pasien masuk lewat IGD
	Dokter Spesialis (DPJP)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	UGD/Poli
2. ASESMEN LANJUTAN	Pemeriksaan DPJP	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Visite dokter
	Co-Dokter jaga	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dokter jaga
3. LABORATORIUM	Darah Lengkap	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	LFT, RFT, SE, GDA	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Rapid tes HIV	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	TCM	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Rapid Antigen covid	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Albumin	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. RADIOLOGI / IMAGING	USG Abdomen / Thorax	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Jika ada indikasi
	Foto Thorax	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Jika ada indikasi
	EKG	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	jika usia > 40 th
5. KONSULTASI	IPD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Jika ada indikasi
6.TATA LAKSANA MEDIS									
	Medikamentosa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Injeksi	Antrain k/p	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Simptomatis
	Asam Tranexamat k/p	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Simptomatis
	Ranitidin / ppi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Simptomatis
Cairan Infus	NS, RL	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Obat Oral	Rifampisin, INH, Pirazinamid, Etambutol	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	Vit B6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	jika perlu
	NAC/ codein	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	jika perlu
Tindakan	oksigen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	jika perlu
	nebulizer Combivent / puilmicort	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	jika perlu
7.Dokter DPJP	Monitoring tanda vital	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	Monitoring perjalanan penyakit pasien	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
8. Informasi & Edukasi	Penjelasan Diagnosis, Rencana terapi/tindakan, Risiko, Komplikasi, Prognosis	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	oleh DPJP
9. Pengisian Form	Informed Consent bila ada tindakan	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	DPJP
	Lembar Edukasi	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Seluruh PPA bersama Pasien
10. Mobilisasi	1.Tirah Baring	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
	2. Duduk di Tempat tidur	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	
	3. Aktivitas harian mandiri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
11. EVALUASI OUTCOME									
Keluhan	Bebas sesak batuk dan demam	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
	Suhu axilla <37,5, Rhonki (-)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
Pemeriksaan Klinis	Pasien pulih pasca perawatan tanpa komplikasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	

2. Intervensi Gizi	Kekurangan asupan cairan per oral berkaitan dengan demam, muntah, tidak dapat mencukupi kebutuhan ditandai dengan asupan cairan 60% dari kebutuhan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	atau diagnosis berubah selama perawatan.
	Edukasi dan konseling gizi								
	Pemberian edukasi dan konseling gizi kepada pasien, keluarga pasien dan penunggu pasien (Care Giver) mengenai diet tinggi energi tinggi protein.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Edukasi gizi dilakukan pada saat awal masuk (pada hari pertama atau kedua) dan atau pada hari ke 4 atau ke 5.
	Tata Laksana / Intervensi								
	a. Diet TKTP (makanan lunak atau makanan biasa)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	kebutuhan zat gizi disesuaikan dengan usia dan kondisi klinis pasien secara
	b. Cukup cairan dari makanan dan minuman	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Monitoring dan Evaluasi (Monitor Perkembangan Pasien)								
	a. Monitoring asupan makan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tanda gejala yang akan dilihat kemajuannya.
	b. Monitoring antropometri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Monev pada hari ke 4 atau ke 5.
	c. Monitoring Biokimia	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Mengacu pada IDNT (International Dietetics & Nutrition Terminology)
	d. Monitoring fisik / klinis terkait gizi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Hasil								
a. Asupan Makan >80%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Status gizi berdasarkan antropometri, biokimia, fisik/klinis	
b. Asupan Cairan (minum) adekuat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
c. Status Gizi Optimal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
KESIMPULAN : Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :									
Nama KaRu									
Kategori		TIDAK PATUH							
12. Discharge Planning	discharge risk assesment, penatalaksanaan discharge planning sesuai dengan discharge risk assesment, discharge planning, daftar obat - obatan dan jadwal kontrol dokter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	MPP	
13. Ringkasan Pulang	Pembuatan Resume, Ringkasan Pulang, penjelasan perkembangan penyakit terkait terapi dan tindakan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Oleh DPJP	
KESIMPULAN : Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :									
Nama DPJP									
Kategori		TIDAK PATUH							
GIZI									
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Pengkajian awal asuhan gizi di rawat inap	1. Data Subjektif								
	a. Lihat resiko malnutrisi melalui skrining gizi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	b. Mengkaji data antropometri, biokimia, fisik/klinis, riwayat makan, alergi makanan serta riwayat personal. asesmen dilakukan dalam waktu 1x24jam.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1. Diagnosis Gizi									
	NI-2.1								
	Peningkatan kebutuhan energi expenditure berkaitan dengan hipermetabolisme ditandai dengan adanya benjolan/ benda asing dalam tubuh	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sesuai dengan data asesmen, kemungkinan saja ada diagnosis lain atau diagnosis
	NI-3.1								

FARMASI										
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7		
		HARI DIRAWAT								
		1	2	3	4	5	6	7		
1. Pengkajian Awal Asuhan Kefarmasian di Rawat Inap	1. Data Subjektif									
	a. Riwayat Alergi Obat	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Riwayat Pengobatan Pasien	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	c. Riwayat Efek Samping Obat	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2. Intervensi Farmasi	1. Asesmen Farmasi								dengan intervensi farmasi yang sesuai hasil Telaah dan	
	a. Telaah Resep	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
	b. Rekonsiliasi Obat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
	2. Edukasi Farmasi									
	a. Informasi Obat	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Pemberian OAT sebelum makan	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Meningkatkan kepatuhan pasien meminum/ menggunakan obat	
	b. Konseling Obat	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Konseling ESO OAT dan penanganan	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
	Konseling kepatuhan OAT	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
	Konseling penggunaan obat inhalasi	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
	3. Tata Laksana/ Intervensi Farmasi								Sesuai dengan hasil monitoring	
	Rekomendasi kepada DPJP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	4. Monitoring dan Evaluasi									
	a. Monitoring Interaksi Obat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Dilanjutkan dengan intervensi farmasi yang sesuai
b. Monitoring Efek Samping Obat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
c. Pemantauan Terapi Obat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
d. Kepatuhan Pasien Minum Obat	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5. Hasil										
	a. Terapi Obat Sesuai Indikasi	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Meningkatkan kualitas hidup/ kualitas hidup pasien	
	b. Obat Rasional	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
	Pemilihan Antibiotik Rasional	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
	6. Ringkasan Pulang									
	a. Terapi Obat Pulang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	kepatuhan minum obat pasien di	
	b. Edukasi Obat Pulang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		
KESIMPULAN :		Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :								
Nama KaRu										
Kategori	TIDAK PATUH									
KEPERAWATAN										
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7		
		HARI DIRAWAT								
		1	2	3	4	5	6	7		
1. Pengkajian awal keperawatan rawat inap	1. Data Subjektif									
	a. Dispnea	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Sulit bicara	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	c. Ortopnea	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	2. Data Objektif	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	a. Gelisah	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Sianosis	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	c. Bunyi napas menurun	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	d. Frekuensi napas berubah.	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	e. Pola napas berubah.	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2. Intervensi keperawatan	Latihan Batuk Efektif									
	Observasi									
	a. Identifikasi kemampuan batuk	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

	b. Monitor adanya retensi sputum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	c. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	d. Monitor input dan output cairan (mis. jumlah dan karakteristik)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Terapeutik									
	Atur posisi semi-Fowler atau Fowler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Edukasi									
	a. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	c. Anjurkan mengulangitarik napas dalam hingga 3 kali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	d. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Kolaborasi									
	Kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik, ekspektoran	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	bila perlu	
	Manajemen Jalan Nafas									
	Observasi									
	a. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Monitor bunyi napas tambahan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(mis. gurgling, mengi, wheezing, ronchi kering)	
	c. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Terapeutik									
	a. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan head-tilt dan chin-lift (jaw-thrust jika curiga trauma servical)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Posisikan semi-fowler atau fowler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	c. Berikan minum hangat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	d. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	e. Lakukan penghisapan lender kurang dari 15 detik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	f. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Edukasi									
	a. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontraindikasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Ajarkan tehnik batuk efektif	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Kolaborasi									
	a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Pemantauan Respirasi									
	Observasi:									
	a. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	b. Monitor pola napas (bradipnea, takipnea, hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes, biot, ataksik)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	c. Monitor kemampuan batuk efektif	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	d. Monitor adanya produksi sputum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	e. Monitor adanya sumbatan jalan napas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	f. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	g. Auskultasi bunyi napas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	h. Monitor saturasi oksigen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	i. Monitor nilai AGD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	j. Monitor hasil x-ray toraks	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Terapeutik									

	a. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Dokumentasikan hasil pemantauan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Edukasi								
	a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
KESIMPULAN :									
Nama KaRu									
Kategori		TIDAK PATUH							
Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :									

Malang, 03 Januari 2025

Ketua Komite Medik

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Ketua Tim Pengendalian
TBC Strategi DOTS

dr. Andy, Sp. P(K)

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah